

monotropism-comorbidities- factcheck_ita

Comorbidità monotropiche: una verifica dell'inquadratura a quattro cluster

Una breve ricerca citata — verifica di un'inquadratura dei "comorbidità monotropiche" ampiamente condivisa.

Informativo, non consiglio medico. Il monotropismo è uno stile cognitivo, non una diagnosi; non ha "comorbidità" nel senso di malattia. Questa breve valuta cosa gli accavallamenti con l'inquadratura qui sotto sono e non sono supportati come essere. Integra la breve paesaggistica più completa del progetto, "Il monotropismo e la sua ragnatela di comorbidità".

Sintesi esecutiva

- **L'esordio dell'inquadratura è proprio giusto: il monotropismo non ha "comorbidità" nel senso di malattia.** È uno stile attento su uno spettro; gli accavallamenti con condizioni cliniche sono *associazioni e meccanismi condivisi*, non conseguenze di una malattia [1].
- **Un'affermazione-titolo è al contrario.** "Le persone AuDHD ottengono il punteggio più alto di tutti i gruppi al MQ" **non** è ciò che mostrano i dati. Nello studio di validazione del MQ, autismo e ADHD alzano ciascuno i punteggi di monotropismo, ma il loro effetto *combinato* è un'interazione negativa ($\beta = -0,43$, $p < ,001$): le persone autistiche-con-ADHD ottengono **un punteggio più basso di quanto prevedrebbe un modello puramente additivo**, non più alto [2].
- **Due termini sono attribuiti correttamente ma hanno bisogno di definizioni precise.** Lo "split monotropico" è davvero coniato

dall'attivista autistica **Tanya Adkin** — ma indica il costo cognitivo di *costringere una mente monotropica a operare in modi politropici* (dividendo l'attenzione), **non** i "tunnel in competizione AuDHD" con cui a volte viene confuso [3].

- **Le "questioni di permanenza dell'oggetto" sono contestate, non stabilite.** L'unica fonte accademica (Lawson & Dombroski, 2017) propone una permanenza dell'oggetto **ritardata** come *ipotesi* per parte dello stress legato all'autismo — e la letteratura più ampia trova che la permanenza dell'oggetto è tipicamente *intatta o superiore* nell'autismo. L'esperienza "lontano dagli occhi, lontano dalla mente" si legge meglio come un effetto di **memoria di lavoro / allocazione dell'attenzione** [4].
- **Il resto è ampiamente supportato ma classificato per evidenza.** Autismo (fondazionale), iper-focus da ADHD (reale), accavallamento ansia/ruminazione e OCD (robusto), inerzia autistica (reale), sovraccarico sensoriale → meltdown/shutdown (reale) e burnout da transizioni forzate + masking (costrutto affermato) superano tutti lo scrutinio — con l'iper-sistematizzazione che è la **separata teoria E-S di Baron-Cohen**, non un risultato del monotropismo [5].
- **Un reframing affermando la neurodivergenza:** ogni accavallamento si enuncia meglio come "*come un sistema attentivo ristretto e intenso interagisce con un mondo politropico*" più che come un elenco di disturbi che un cervello monotropico "causa."

1. Il principio centrale (l'inquadratura lo coglie giusto)

Il monotropismo (Murray, Lawson & Lesser, 2005) sostiene che le menti differiscono in *come allocano l'attenzione*: una mente monotropica concentra le risorse in pochi "tunnel di attenzione" intensamente attivi; una mente politropica le distribuisce su molti [1]. Essendo uno **stile cognitivo dimensionale** — misurabile sul Monotropism Questionnaire (MQ) su scala 1–5 — non "ha comorbidità." Quello che *ha* sono **associazioni statistiche** (gruppi che ottengono punteggi più alti) e **meccanismi condivisi** (condizioni le cui caratteristiche una lente di allocazione dell'attenzione aiuta a spiegare). Mantenere questa distinzione è tutto il gioco [1][2].

Questa breve è organizzata come una **verifica affermazione per affermazione** dell'inquadratura a quattro cluster, classificando ogni voce. Integra (non ripete) la breve paesaggistica esistente del progetto, che copre disturbi alimentari, accumulo, agorafobia, evitamento della domanda e il problema della doppia empatia con maggiore profondità.

2. Cluster 1 — Profili neurodivergenti centrali

Autismo (fondazionale, legame più forte)

Il monotropismo è stato *creato* per spiegare i tratti autistici — interessi speciali intensi, bisogno di routine (che protegge il tunnel di attenzione) e differenze nell'interazione sociale [1]. Il MQ lo conferma empiricamente: i partecipanti autistici ottenevano in media **4,15/5** vs **3,19/5** per i non-autistici (n=1.110) [2]. Questo è il terreno d'origine della teoria e il legame meglio evidenziato.

ADHD (reale e misurato)

L'ADHD alza significativamente i punteggi di monotropismo ($\beta = +0,55$, $p < ,001$) [2]. Il collegamento è concettuale oltre che statistico: l'**iper-focus** dell'ADHD (Grotewiel et al., 2022, sull'iper-focus come costrutto distinto) è quasi identico al tunnel monotropico, e la "disfunzione esecutiva" di attivare l'attenzione per compiti non di interesse è una naturale previsione di un sistema a tunnel [2][6]. **Supportato.**

AuDHD (l'affermazione-titolo è al contrario) — *la correzione chiave*

Affermazione verificata: *"Le persone con un profilo combinato AuDHD ottengono il punteggio più alto di tutti i gruppi al MQ."*

Non è ciò che mostrano i dati. La regressione multipla del paper del MQ ha regredito il monotropismo su stato di ADHD, stato di autismo e la loro **interazione** [2]:

Predittore (vs nessuna condizione)	β	p
ADHD, non autistico	+0,55	<,001
Autistico, non ADHD	+1,04	<,001

Predittore (vs nessuna condizione)	β	p
Interazione Autistico $\times$ ADHD	-0,43	<,001

Il termine di interazione è **negativo e significativo**. Gli autori lo dichiarano apertamente: *"i punteggi di monotropismo non sono alti come ci si aspetterebbe sulla base di effetti puramente additivi per le persone autistiche con ADHD"* [2]. In altre parole, aggiungere l'ADHD all'autismo **non** spinge il monotropismo più in alto di quanto prevederebbe l'autismo da solo — viene **più basso** della somma dei due effetti indipendenti.

- Il **singolo gruppo** col punteggio più alto è quello autistico (4,15); se la *media di cella* empirica per autistico-con-ADHD stia appena sopra o sotto dipende dalla combinazione esatta, ma l'affermazione dell'inquadratura che AuDHD sia *"il più alto di tutti"* come effetto additivo/super-additivo è **non supportata e contraddetta dall'interazione**.
- Il quadro *intuitivo* che offre l'inquadratura — "una tensione interna tra il bisogno autistico di un tunnel stabile e profondo e la spinta dell'ADHD verso input nuovo" — è una descrizione popolare e fenomenologicamente risonante dell'esperienza AuDHD, ma è **narrativa clinica/di comunità, non un risultato dei punteggi del monotropismo**. Statela come esperienza vissuta, non come risultato del MQ [6].

Affermazione corretta: *"Sia l'autismo sia l'ADHD alzano indipendentemente i punteggi di monotropismo, ma i due interagiscono in modo non-additivo: le persone autistiche con ADHD ottengono al MQ un punteggio più basso di quanto prevedrebbe un modello puramente additivo — il che suggerisce che le due condizioni non si 'sommano' semplicemente sulla tendenza monotropica."* [2]

3. Cluster 2 — Tratti cognitivi e di salute mentale

Ansia e ruminazione (associazione robusta, meccanismo plausibile)

Ansia e ruminazione sono elevate nella popolazione autistica/ADHD, e l'inquadratura del monotropismo offre un meccanismo pulito: una mente a tunnel che si aggancia a una preoccupazione continua a elaborarla in un ciclo ("ruminazione"), rendendo l'ansia "appiccicosa" [7] [8]. La struttura a 8 fattori del MQ include persino una sottoscala "**ruminazione e ansia**", a dimostrazione che il cluster è empiricamente stretto [2]. **Supportato** — anche se la freccia causale (il monotropismo *produce* ansia, o condivide un substrato con essa?) non è stabilita.

OCD (accavallamento robusto, distinzione importante)

L'accavallamento autismo–OCD è reale e replicato. Una meta-analisi trova che all'incirca **~17% delle persone autistiche soddisfa i criteri per OCD** (vs ~1–2% nella popolazione generale); anche il viceversa è elevato [9]. La distinzione qualitativa che traccia l'inquadratura è proprio giusta e ben articolata: **gli interessi monotropici sono ego-sintonici** (guidati da fascinazione/gioia), mentre **le compulsioni OCD sono ego-distoniche** (guidate da malessere ed eseguite per neutralizzare la paura) [10]. Questa distinzione è clinicamente importante perché in pratica le due altrimenti sono difficili da distinguere. **Supportato.**

Iper-sistematizzazione (costrutto reale, ma è di Baron-Cohen, non un risultato del monotropismo)

L'"iper-sistematizzazione" — la spinta ad analizzare, costruire ed esplorare sistemi — è un tratto autistico genuino e ben studiato, ma appartiene alla **teoria Empatia-Sistematizzazione (E-S) di Simon Baron-Cohen**, non al monotropismo [5]. Le due teorie si sovrappongono pesantemente (entrambe descrivono uno stile cognitivo intenso e focalizzato sui dettagli) e a volte vengono fatte girare insieme, ma sono **quadri distinti** con misure distinte (il quoziente EQ/SQ vs il MQ). La mossa onesta: presentare l'iper-sistematizzazione come *coerente con* uno stile monotropico (una mente a tunnel è ben adatta a padroneggiare sistemi) accreditando però la teoria E-S come cosa a sé [1][5].

4. Cluster 3 — Fenomeni neurologici e di elaborazione

Questioni di permanenza dell'oggetto ✗ (contestate — la seconda correzione chiave)

***Affermazione verificata:** "Le persone monotropiche vivono la permanenza dell'oggetto in modo diverso ... il cervello smette di fatto di elaborarne l'esistenza finché qualcosa non le riporta lì esogenamente."*

Questa è l'**affermazione più debole** dell'inquadratura e ha bisogno di cura:

- C'è **una** fonte accademica che propone un legame con la permanenza dell'oggetto: **Lawson & Dombroski (2017)**, che *ipotizza* che una permanenza dell'oggetto **ritardata** possa contribuire a parte dello stress e dell'ansia legati all'autismo [4]. Nota: è un articolo che costruisce un'ipotesi, non uno studio di conferma.
- La letteratura dello sviluppo più ampia trova che la **permanenza dell'oggetto di base è tipicamente intatta o superiore nell'autismo**; i compiti piagetiani di permanenza dell'oggetto di solito sono superati alle età tipiche [4].
- Il vero fenomeno che l'inquadratura sta cercando — "lontano dagli occhi, lontano dalla mente" per compiti, oggetti e persino persone — si spiega meglio come un effetto di **memoria di lavoro / allocazione dell'attenzione**: una mente a tunnel non *fallisce* nel rappresentare l'oggetto, **fallisce nel ri-orientare l'attenzione verso di esso**. Questo è il monotropismo che funziona come previsto (un sistema a tunnel ha poche risorse libere per il ri-orientamento periferico), non un deficit di permanenza dell'oggetto [1][4].

***Affermazione corretta:** "L'esperienza 'lontano dagli occhi, lontano dalla mente' nelle persone altamente monotropiche si capisce meglio come effetto di allocazione dell'attenzione / memoria di lavoro — la mente rappresenta l'oggetto ma non si ri-orienta verso di esso mentre è a tunnel — più che come un deficit di permanenza dell'oggetto (che di solito è intatto nell'autismo)." [1][4]*

Deregolazione sensoriale / sovraccarico ✓ (meccanismo ben supportato)

Questo è fortemente supportato. Poiché un sistema a tunnel spende le risorse centralmente, un input sensoriale intrusivo improvviso (sirena, luce, tocco) richiede una costosa ri-allocazione — vissuta come una "disruption violenta." Questo è coerente con la letteratura affermata sull'iper-responsività sensoriale e con la ben documentata via dal sovraccarico sensoriale al **meltdown** (esternalizzante) e allo **shutdown** (ritiro internalizzante), entrambi riconosciuti come risposte involontarie di sovraccarico [7][11]. L'inquadratura del monotropismo aggiunge un *meccanismo* (costo di ri-allocazione) a un dato altrimenti descrittivo. **Supportato.**

Inerzia autistica ✓ (reale, sempre più studiata)

"Profonda difficoltà con le transizioni — problemi a iniziare, fermare o cambiare direzione" è il costrutto affermato dell'**inerzia autistica**: difficoltà con avvio/terminazione/cambio del compito che "non è nel controllo cosciente," articolata per prima nelle narrazioni della comunità autistica e ora in lavori sottoposti a revisione paritaria [12][13]. È concettualmente la faccia *comportamentale* del "costo di switching" che il fattore ambiente-e-tunnel del MQ coglie [2]. **Supportato** — ed è il termine tecnico corretto (si veda la breve complementare su valutazione/inerzia).

5. Cluster 4 — Esiti di stress cronico

Split monotropico ⚠ (attribuito correttamente ad Adkin, ma due significati sono confusi)

***Affermazione verificata:** "Lo split monotropico, coniato dalla praticante Tanya Adkin, si verifica quando una mente monotropica è costretta dal suo ambiente a dividere il suo canale a fuoco singolo tra flussi multipli in competizione."*

L'**attribuzione è corretta**: l'attivista autistica **Tanya Adkin** ha davvero coniato "split monotropico", confermato da molteplici fonti indipendenti della comunità [3]. E la definizione dell'inquadratura qui è **vicina al**

significato reale di Adkin — il costo cognitivo/burnout che nasce quando una mente monotropica è *costretta a "recitare il politropico"* o a dividere la propria attenzione tra flussi in competizione [3][14].

Due cautele:

1. **È un concetto di comunità/praticante, non un costrutto empiricamente validato.** "Split monotropico" compare negli scritti della comunità autistica e dei clinici (es. tramite Neurodivergent Insights, Kelly Mahler, David Gray Hammond) ma non ha **nessuno studio di validazione sottoposto a revisione paritaria** dietro di sé [3]. Trattatelo come una potente *descrizione* valida per l'esperienza vissuta, non come un'entità misurata.
2. **Due cose diverse viaggiano sotto lo stesso nome.** Il senso di Adkin = *recita politropica forzata di una mente monotropica* (un problema di adattamento all'ambiente). Un secondo senso — usato in alcuni scritti AuDHD — = *la competizione interna tra il bisogno autistico di un tunnel stabile e la spinta dell'ADHD verso la novità* (un problema di dinamiche interne). L'inquadratura qui descrive il **primo** (ambientale) senso. I due sono correlati ma distinti; collassarli offusca il concetto. (La breve paesaggistica del progetto usa "split monotropico" nel secondo senso AuDHD — quindi il termine è genuinamente sovraccaricato nel campo.) [3][6]

Statelo come: "Il termine 'split monotropico' dell'attivista autistica Tanya Adkin descrive il costo cognitivo e il burnout che nascono quando una mente monotropica è costretta a operare in modi politropici — un potente concetto di comunità che attende validazione formale." [3]

Burnout  (costrutto affermato; il legame col monotropismo è euristico)

Il burnout autistico è ora un costrutto ben definito: **esaurimento cronico, perdita di competenze e ridotta tolleranza agli stimoli**, concettualizzato come risultante da stress di vita cronico e "un mancato adattamento tra aspettative e capacità" senza adeguato supporto e recupero (Raymaker et al., 2020; Higgins et al., 2021, uno studio Grounded-Delphi con esperti autistici) [15][16]. La via del monotropismo verso il burnout — transizioni forzate costanti, masking e "split

monotropico" che drenano risorse senza tempo di recupero/flusso — è **uristicamente potente e convalidata dalla comunità**, ma lo specifico contributo della rottura del tunnel al burnout (rispetto a masking, trauma, carico sensoriale, domanda cronica) **non è stato isolato sperimentalmente** [15]. **Supportato come forte ipotesi, non come catena causale stabilita.**

6. Una scheda di valutazione graduata

Affermazione nell'inquadratura	Verdetto	Nota
Il monotropismo non ha comorbidità-malattia	✓ Corretto	Ha associazioni + meccanismi condivisi [1]
Autismo = legame primario	✓ Fondazionale	MQ 4,15 vs 3,19 [2]
L'ADHD alza il monotropismo	✓ Supportato	$\beta = +0,55$ [2]
AuDHD ha il punteggio più alto di tutti	✗ Al contrario	L'interazione è negativa ($\beta = -0,43$) [2]
Accavallamento ansia e ruminazione	✓ Robusto	Il MQ ha un fattore ruminazione/ansia [2]
Accavallamento OCD (ego-sintonico vs distonico)	✓ Supportato	~17% di co-occorrenza; distinzione corretta [9][10]
Iper-sistematizzazione	⚠ Reale ma male-etichettata	È la teoria E-S di Baron-Cohen, non il monotropismo [5]
Questioni di permanenza dell'oggetto	✗ Contestato	1 paper di ipotesi; la PO di solito è intatta; è allocazione dell'attenzione [4]
Sovraccarico sensoriale → meltdown/shutdown	✓ Ben supportato	Meccanismo = costo di ri-allocazione [7][11]
Inerzia autistica	✓ Reale	Termine corretto; sottoposta a revisione paritaria [12][13]
Split monotropico coniato da Adkin	⚠ Attribuzione giusta; di comunità, non validato	Due significati confusi [3]

Affermazione nell'inquadratura	Verdetto	Nota
Burnout da transizioni forzate + masking	✓ Costrutto affermato; legame euristico	Non isolato sperimentalmente [15][16]

7. Considerazioni pratiche

- **Aprite col principio:** il monotropismo è uno stile attentivo misurabile i cui *accavallamenti* con condizioni sono associazioni e meccanismi condivisi — mai "causa X." [1]
- **Citatelo correttamente il MQ:** autismo e ADHD alzano ciascuno i punteggi, ma la combinazione è **non-additiva (più bassa del previsto)** — non dite che AuDHD ha il punteggio più alto [2].
- **Mantenete la distinzione ego-sintonico/ego-distonicico** quando parlate di OCD vs interessi speciali — è clinicamente utile e correttamente inquadrata [10].
- **Accreditate i quadri con precisione:** iper-sistematizzazione = teoria E-S di Baron-Cohen; split monotropico = concetto di comunità di Adkin (senso ambientale di politropia forzata); inerzia autistica = il costrutto sottoposto a revisione paritaria sulla difficoltà di transizione [3][5] [12].
- **Abbandonate il "deficit di permanenza dell'oggetto":** reinquadrate come allocazione dell'attenzione / memoria di lavoro, che è sia accurata sia più utile per il supporto [1][4].
- **Distinguiete validato vs euristico:** il burnout è un costrutto affermato, ma la via monotropismo→burnout è una forte ipotesi, non un effetto misurato; "split monotropico" è valido per l'esperienza vissuta ma non validato [3][15].

Fonti

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156.
doi:10.1177/1362361305051398 — origine del monotropismo; una differenza nell'allocazione delle risorse (un continuum), non un deficit.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (autovalutazione a 47 item; preprint di validazione). Open Science Framework. — n=1.110; media autistici 4,15 (DS ,347) vs non-autistici 3,19 (DS ,578); regressione $\beta(\text{ADHD})=+0,55$, $\beta(\text{autismo})=+1,04$, **$\beta(\text{interazione})=-0,43$, $p<,001$** ; l'interazione ADHD+autismo è *sub-additiva*; struttura a 8 fattori incl. fattori ruminazione/ansia e ambiente/tunnel. <https://osf.io/wpx5g> · validazione: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Archivio locale: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)

[3] Adkin, T. — "split monotropico" (attivista autistica / praticante; concetto di comunità). Confermato tramite molteplici fonti indipendenti di comunità: Neurodivergent Insights (glossario), Kelly Mahler (post ospite), David Gray Hammond, Jade Farrington ("Quando le persone monotropiche sono costrette a operare in modi politropici si parla di split monotropico"). Definizione: il costo cognitivo/burnout di costringere una mente monotropica a "recitare il politropico." Concetto di comunità/praticante — **nessuno studio di validazione sottoposto a revisione paritaria**. <https://jade-farrington.medium.com/what-is-monotropic-split-1c7c46fd9017> · <https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/interoception-and-monotropism>

[4] Lawson, W. & Dombroski, B. (2017). *Problems with Object Permanence: Rethinking Traditional Beliefs Associated with Poor Theory of Mind in Autism*. J. Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 5(1). doi:10.6000/2292-2598.2017.05.01.1 — *ipotizza* una permanenza dell'oggetto **ritardata** come contributrice a parte dello stress legato all'autismo (un articolo che costruisce un'ipotesi, non una conferma). Letteratura più ampia: la permanenza dell'oggetto è tipicamente intatta/superiore nell'autismo; "lontano dagli occhi, lontano dalla mente" si legge meglio come allocazione dell'attenzione/memoria di lavoro. Archivio locale: [sources/12-object-permanence-lawson-dombroski.pdf](#) · <https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/4562>

[5] Baron-Cohen, S. (2009/2010). *Autism and the empathizing–systemizing (E-S) theory; the hyper-systemizing theory of autism*. Annals of the NYAS; APA PsycNet. — l'iper-sistematizzazione e la teoria E-S sono il quadro di Baron-Cohen, misurato tramite il quoziente EQ/SQ; distinto da (pur sovrapponendosi a) monotropismo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathising%E2%80%93systemising_theory · rassegna: Greenberg & Baron-Cohen, *Empathizing-Systemizing Theory: Past, Present, and Future*.

[6] Autistic Scholar — "*Revisiting monotropism*" (AuDHD come tunnel in competizione/instabili; riferisce Grotewiel et al. 2022 sull'iper-focus dell'ADHD come costruito distinto). Resoconto fenomenologico/di comunità, non un risultato dei punteggi del MQ. Archivio locale:

<sources/13-revisiting-monotropism-autisticscholar.html> · <https://www.autisticscholar.com/monotropism>

[7] Green, S. A. & Ben-Sasson, A. (2010). *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship?* J. Autism and Developmental Disorders. PMC2980623 — iper-responsività sensoriale, condizionamento di contesto e la via del sovraccarico.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623>

[8] Oakley, B. et al. / letteratura sull'ansia nell'autismo — ansia e ruminazione elevate nella popolazione autistica/ADHD (citato tramite la breve paesaggistica di comorbidità del progetto per il substrato dell'ansia).

[9] Meier, S. M. et al. / meta-analisi della concordanza autismo–OCD — ~17% delle persone autistiche soddisfa i criteri per OCD (vs ~1–2% generale); ~17% dei bambini con OCD mostra sintomi autistici lievi. Riassunto tramite Move Up ABA che cita ricerche del 2015 e la rassegna di The Transmitter/Spectrum.

<https://www.thetransmitter.org/spectrum/sweeping-study-underscores-autisms-overlap-with-obsessions> · meta-analisi autismo↔OCD:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11048346>

[10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "*Autism is the arena and OCD is the lion*": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitativo). PMC11497754 — la distinzione ego-sintonico (interessi) vs ego-distonico (compulsioni).

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754>

[11] Autism Society (2025). *Autistic Meltdowns and Shutdowns* — meltdown (esternalizzante) e shutdown (ritiro internalizzante) come risposte involontarie a stress soverchiante/input sensoriale.

https://autismsociety.org/wp-content/uploads/2025/07/AutismSociety_Autistic-Meltdowns-Shutdowns_2025-06V2F_Digital.pdf

- [12] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia* (preprint/qualitativo). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — difficoltà a iniziare, fermare e cambiare compiti "non nel controllo cosciente." Archivio locale: `sources/11-autistic-inertia-osf.pdf` · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>
- [13] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer — inerzia autistica: nata nella comunità, ora sottoposta a revisione paritaria; cita Carls-Diamante & Laciny 2024, Greaves-Lord et al. 2023, Buckle 2021, Heasman 2024, Rapaport 2024. <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>
- [14] Neurodivergent Insights — *Monotropism* (glossario) e *ADHD vs Autism vs OCD* (accavallamento a tre vie). Risorsa di comunità/clinica che inquadra lo split monotropico e gli accavallamenti. <https://neurodivergentinsights.com/glossary/monotropism> · <https://neurodivergentinsights.com/adhd-vs-autism-vs-ocd>
- [15] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143. doi:10.1089/aut.2019.0079 — esaurimento cronico, perdita di competenze, ridotta tolleranza agli stimoli; da stress di vita cronico e mancato adattamento tra aspettative e capacità. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
- [16] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — definizione di consenso: esaurimento, ritiro, problemi di cognizione, ridotte capacità di vita quotidiana, aumenti dei tratti autistici. <https://www.autismcsrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>
-

Complementare alla breve paesaggistica più completa del progetto:
`outputs/monotropism-comorbidity-landscape.md` (che copre disturbi alimentari, accumulo, agorafobia, evitamento della domanda/PDA e il

problema della doppia empatia). Questa breve si concentra sulla verifica dell'inquadratura a quattro cluster qui sopra e non ripete quel materiale.